

Funções do triângulo de ressuscitação



Responsável pela compressão

- Avalia o paciente
- Executa as compressões de acordo com os protocolos locais
- Alterna as pessoas a cada 2 minutos ou antes, se houver cansaço



Responsável pelo desfibrilador/ instrutor de RCP

- Busca e opera o DEA/monitor/desfibrilador e age como o instrutor de RCP, se designado
- Se houver um monitor, coloca-o em uma posição em que possa ser visto pelo líder da equipe (e pela maioria da equipe)

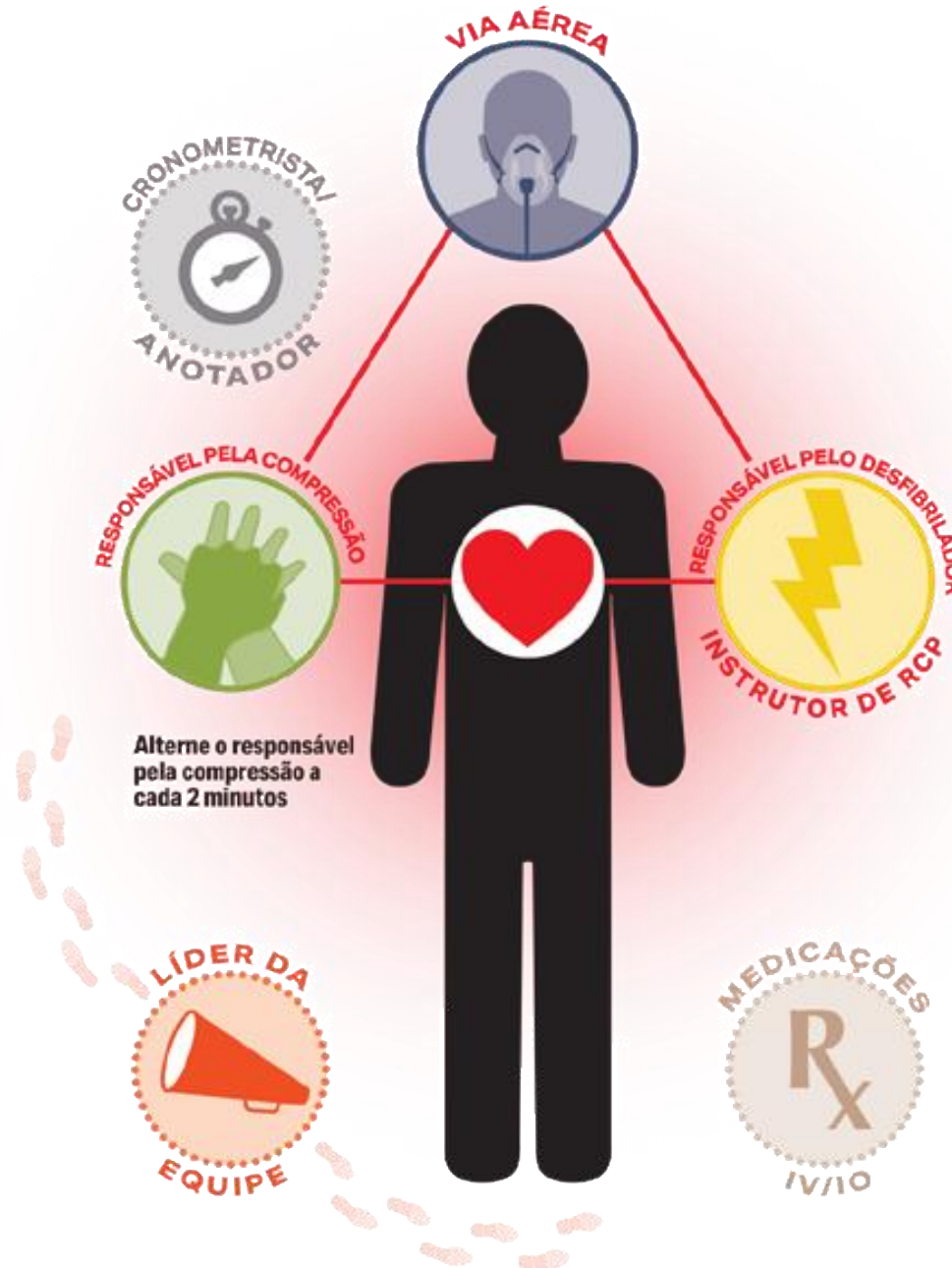


Via aérea

- Abre a via aérea
- Realiza ventilação com bolsa-máscara
- Insere acessórios na via aérea, conforme adequado

A equipe tem seu próprio código. Nenhum membro da equipe deixa o triângulo, a não ser para alternar os responsáveis pelas compressões ou proteger a própria segurança.

Posições em equipes de alto desempenho para 6 pessoas*



Funções de liderança



Líder da equipe

- Toda equipe de ressuscitação deve ter um líder definido
- Atribui funções aos membros da equipe
- Toma decisões de tratamento
- Fornece feedback para o restante da equipe conforme a necessidade
- Assume responsabilidade por funções não atribuídas



Medicações IV/IO

- Uma função do profissional de SAV
- Inicia o acesso IV/IO
- Administra medicações



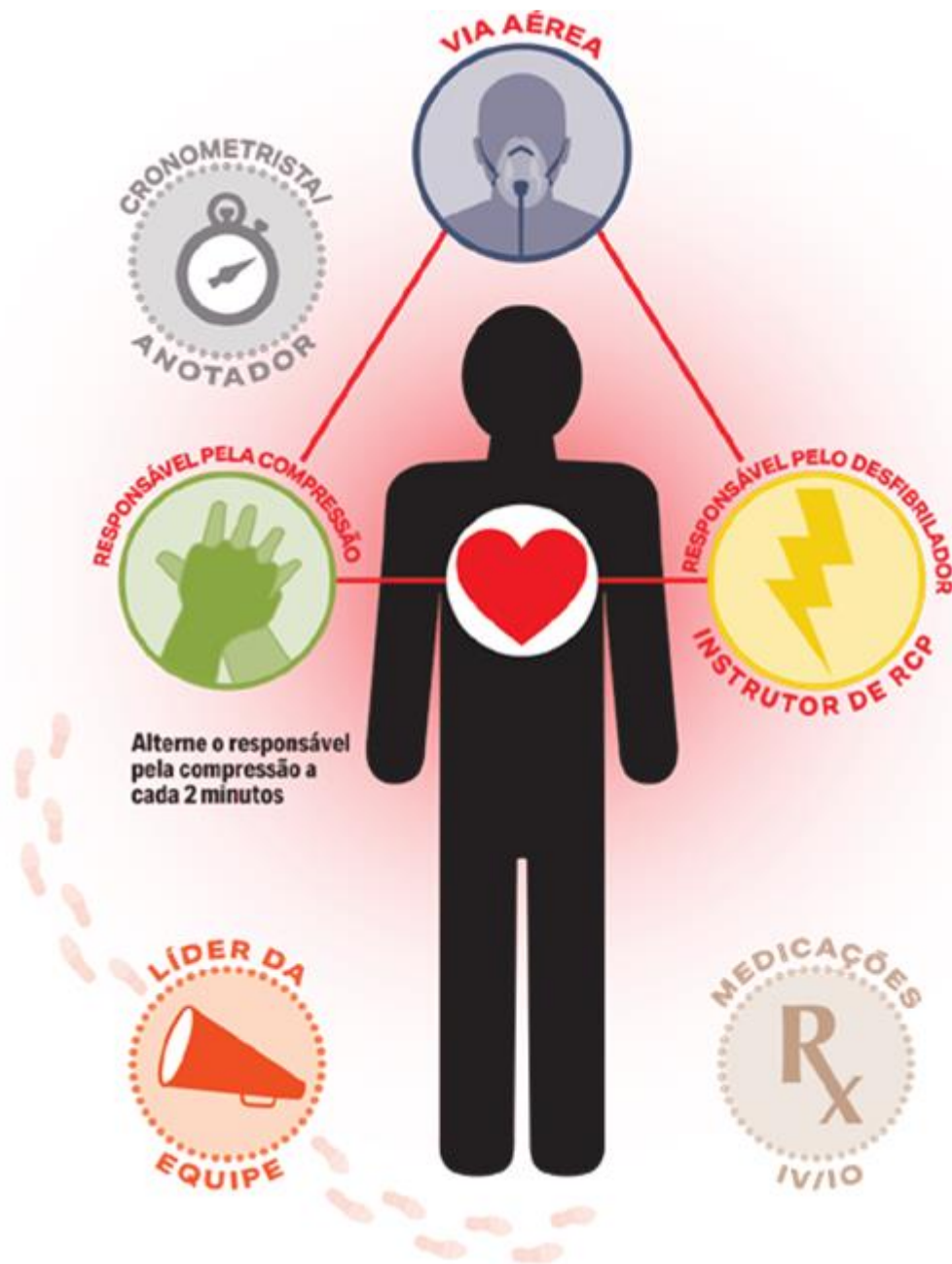
Cronometrista/anotador

- Anota os horários das intervenções e medicações (e comunica quando deverão ocorrer as próximas)
- Anota a frequência e a duração das interrupções das compressões
- Informa isso ao líder da equipe (e ao restante da equipe)

*Trata-se de uma sugestão de formação da equipe. As funções podem ser adaptadas ao protocolo local.

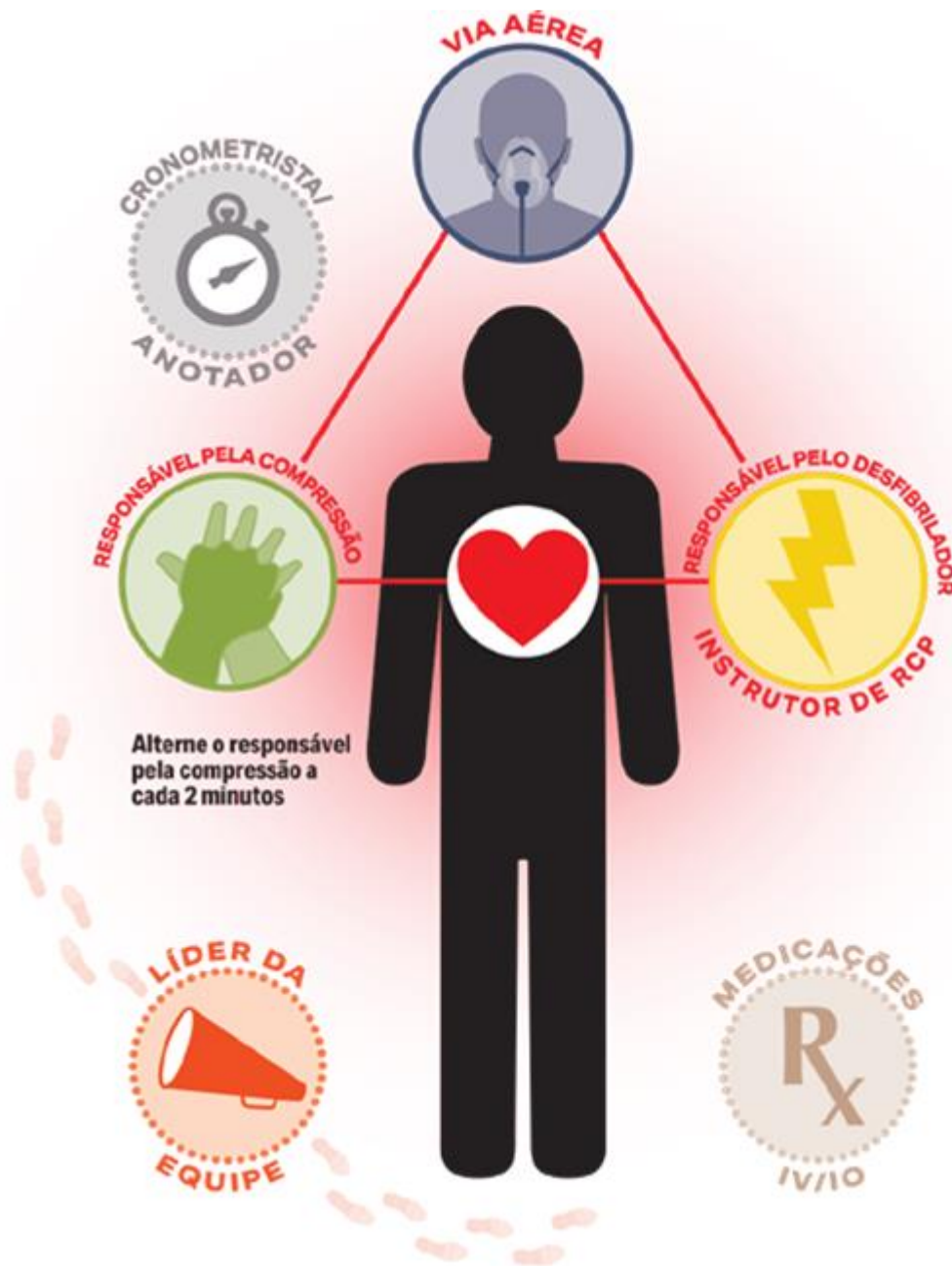
Responsável pela compressão

- Avalia o paciente
- Executa compressões de acordo com protocolos locais
- Alterna as pessoas a cada 2 minutos ou antes, se houver cansaço



Responsável pelo desfibrilador/Instrutor de RCP

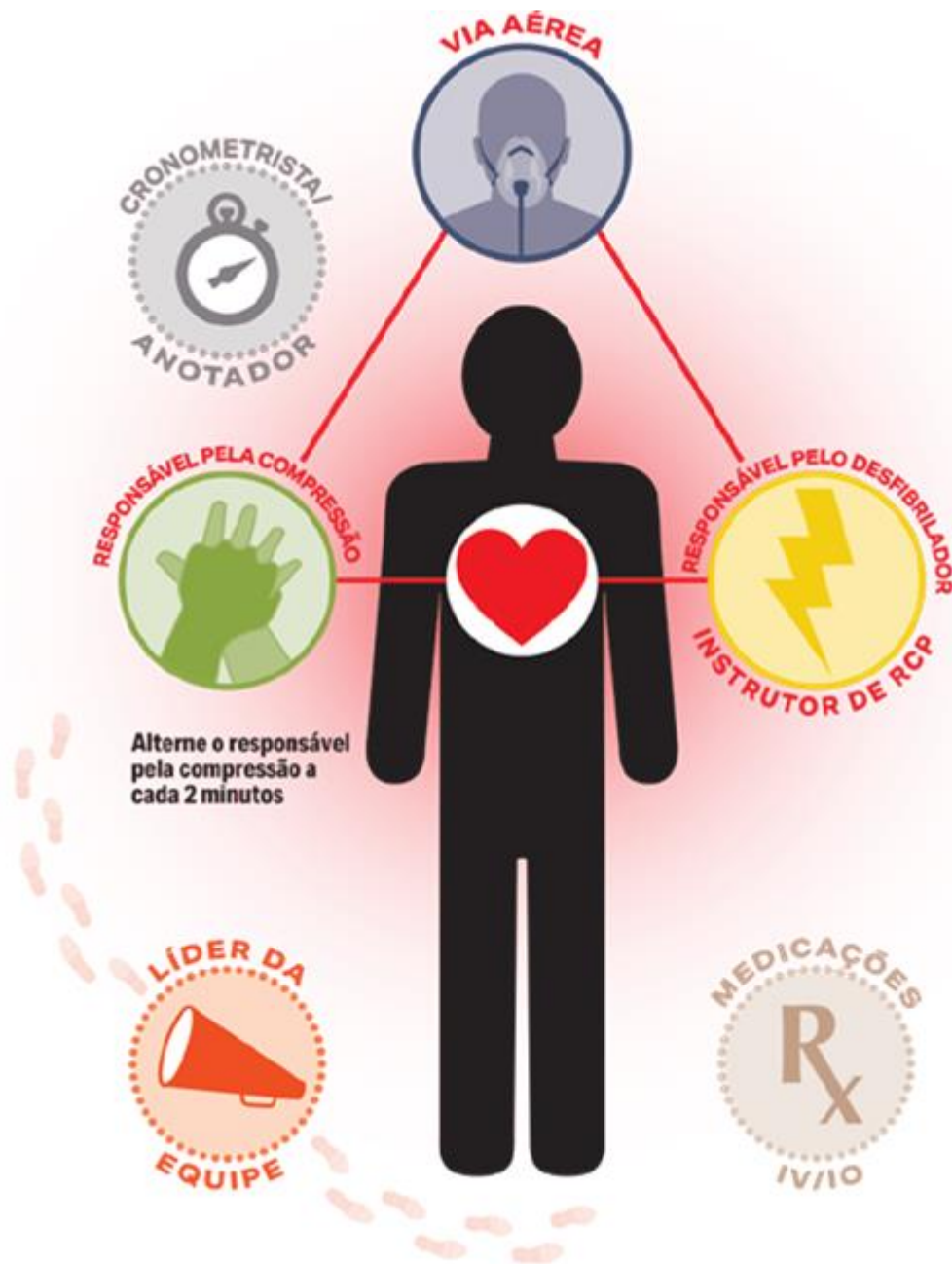
- Busca e opera o DEA/monitor/desfibrilador e age como instrutor RCP, se designado
- Se houver um monitor, coloca-o em uma posição em que possa ser visto pelo líder da equipe (e pela maioria da equipe)





Via aérea

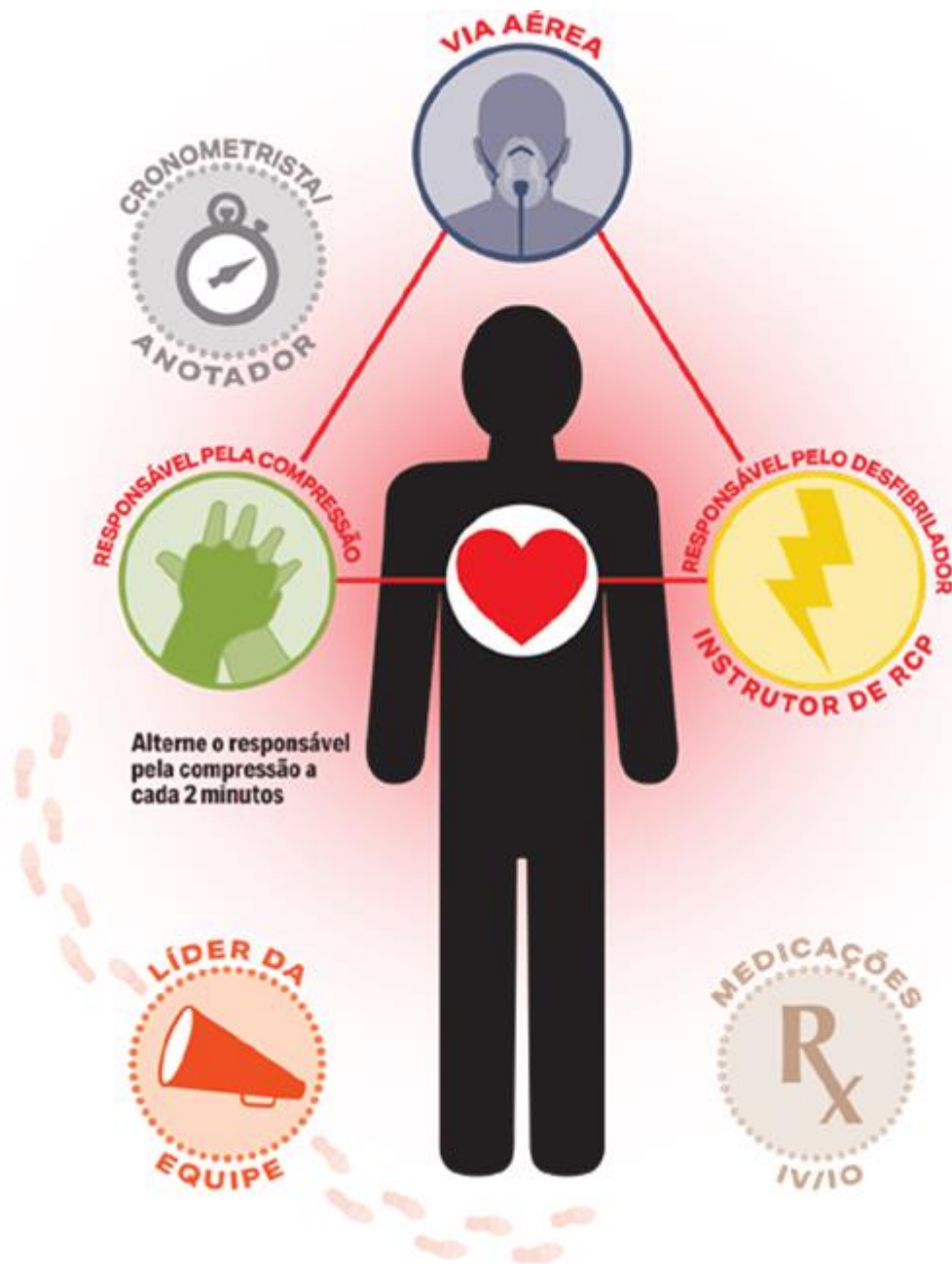
- Abre a via aéreas
- Realiza ventilação com bolsa-máscara
- Insere acessórios na via aérea, conforme adequado



Funções de liderança

Líder da equipe

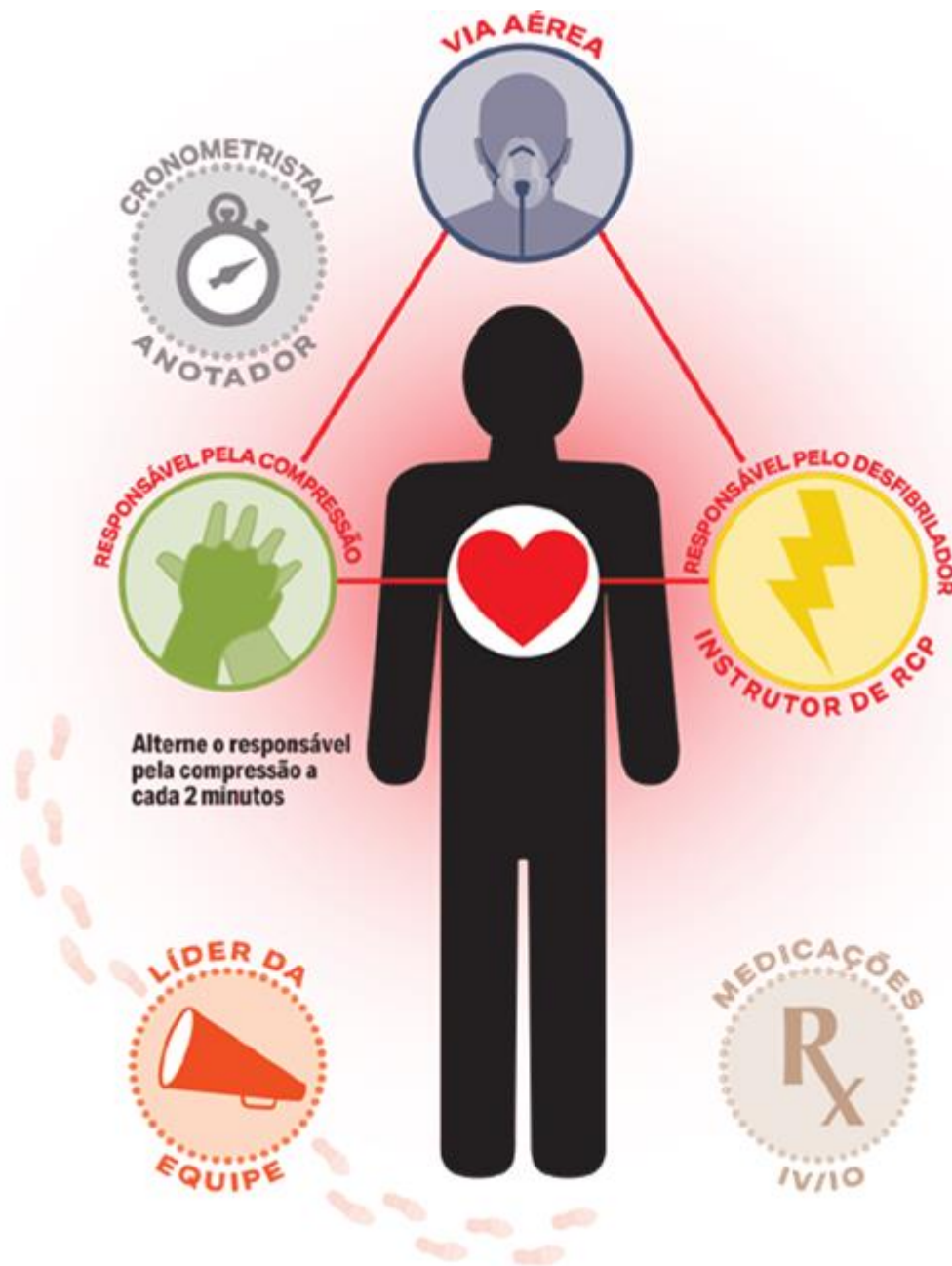
- Toda equipe de ressuscitação deve ter um líder definido
- Atribui funções aos membros da equipe
- Toma decisões de tratamento
- Fornece feedback para o restante da equipe, conforme necessário
- Assume responsabilidade por funções não atribuídas





Medicações IV/IO

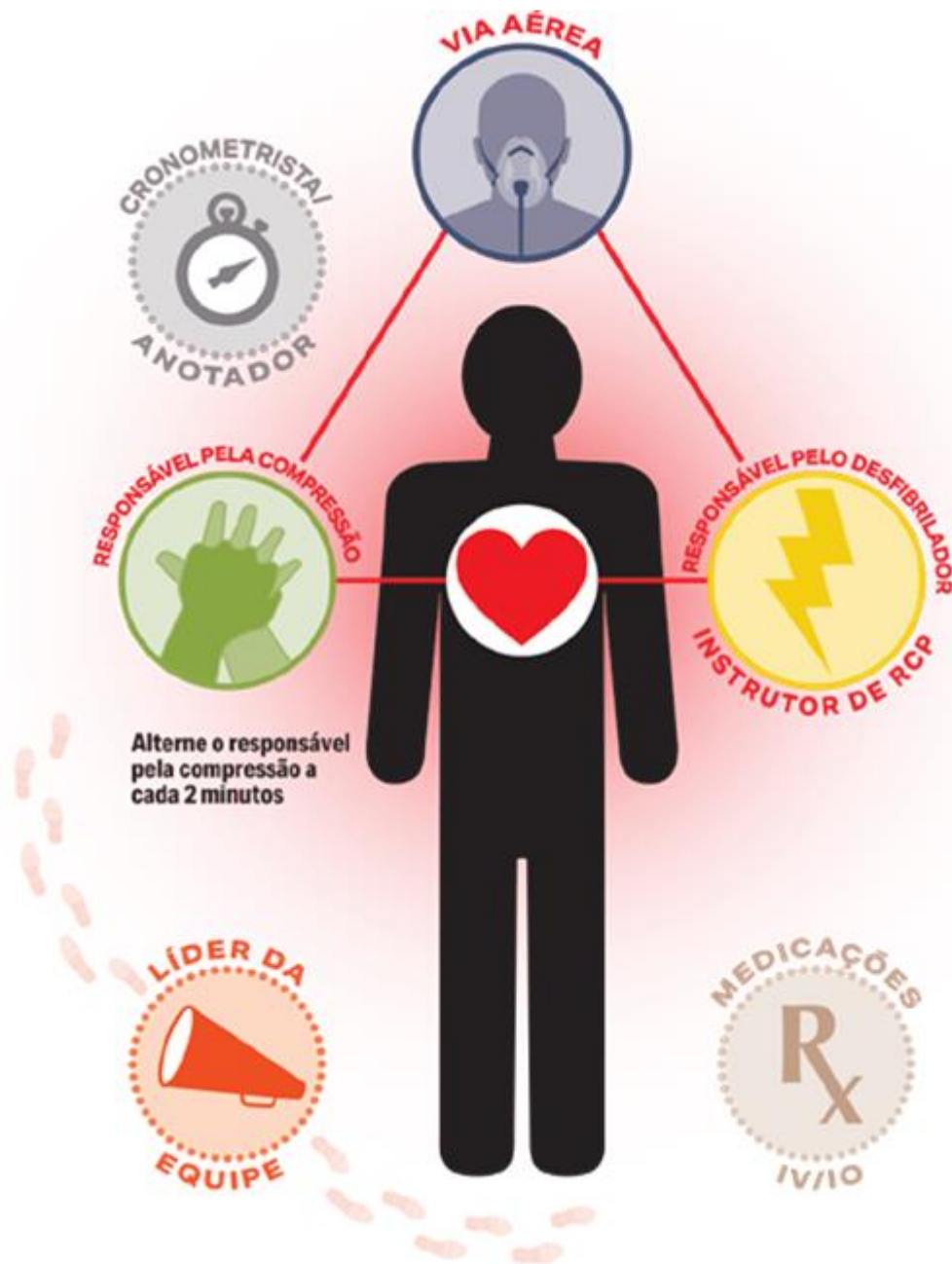
- Uma função de profissional de SAV
- Inicia o acesso IV/IO
- Administra medicações



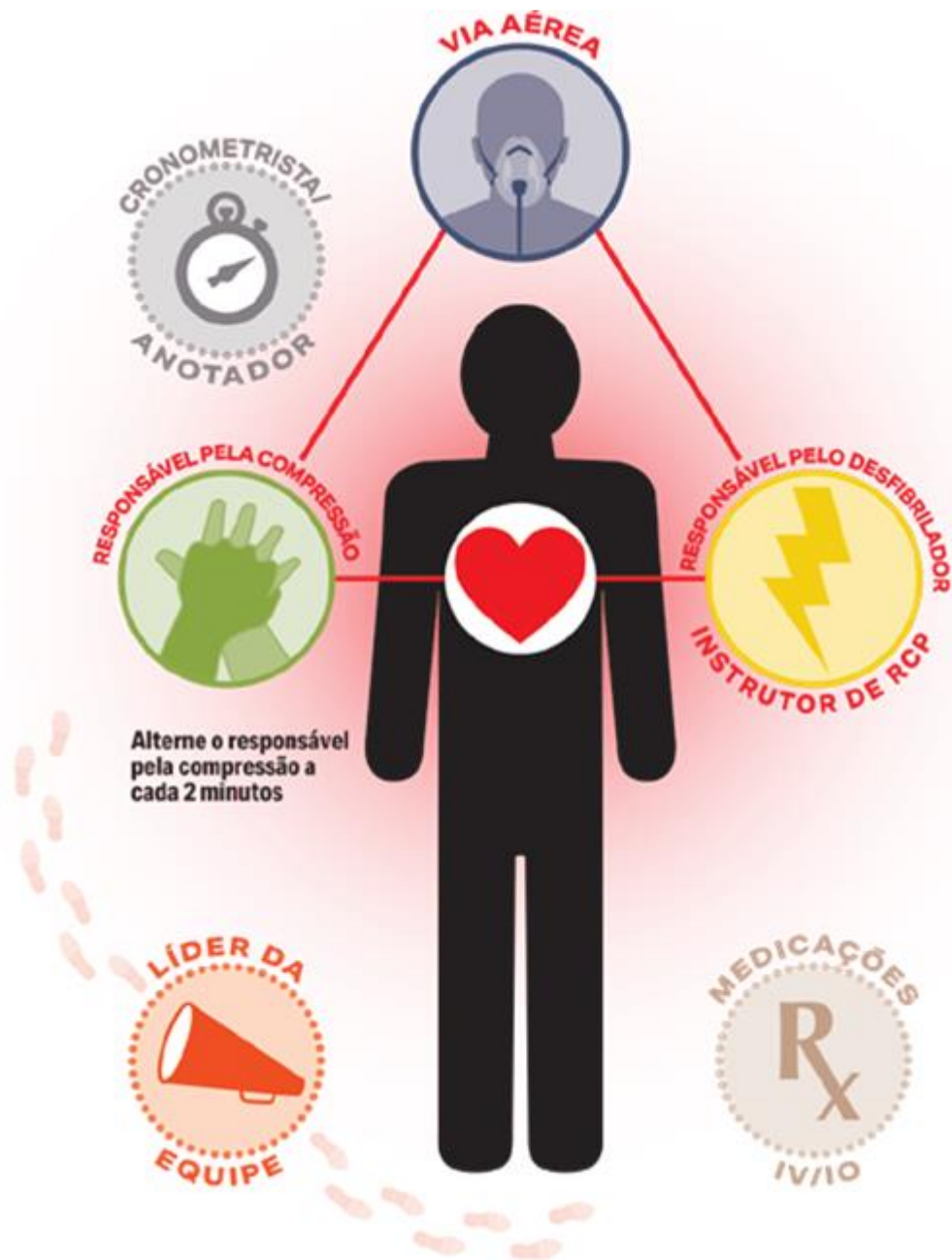


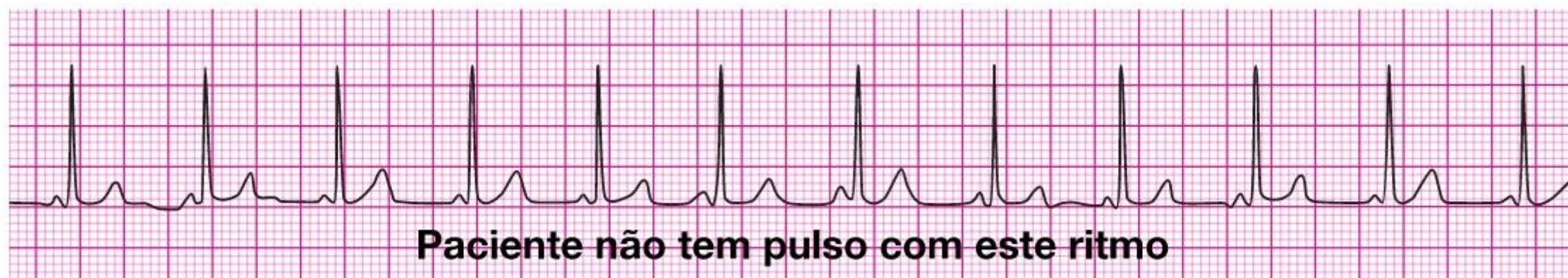
Cronometrista/anotador

- Anota os horários das intervenções e medicações (e comunica quando deverão ocorrer as próximas)
- Anota a frequência e a duração das interrupções das compressões
- Informa isso ao líder da equipe (e ao restante da equipe)



A equipe tem seu próprio código.
Nenhum membro da equipe deixa o triângulo, a não ser para alternar os responsáveis pelas compressões ou proteger a própria segurança



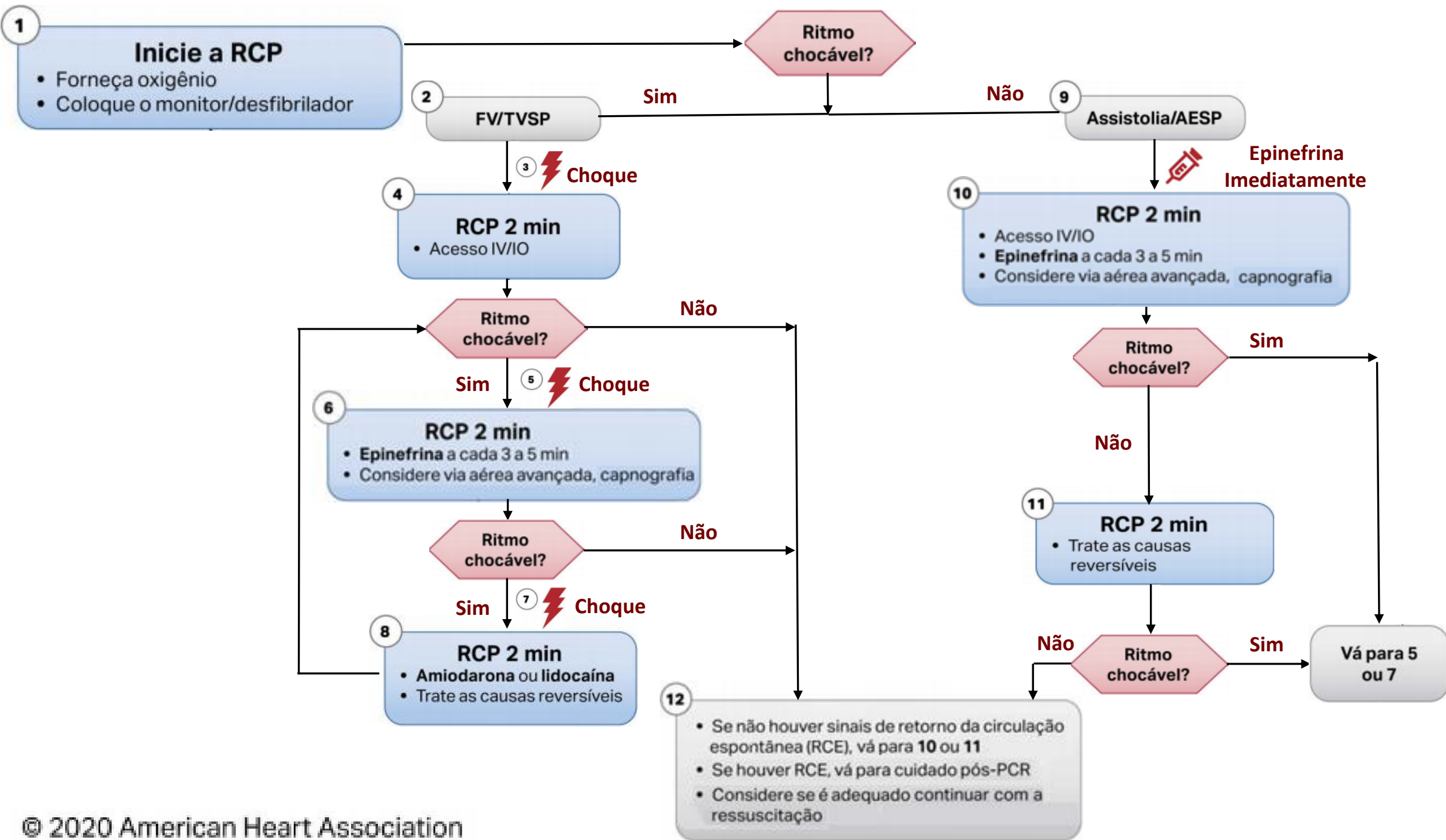




PROTOCOLO DA LINHA RETA

- Toda vez que vemos assistolia no monitor OBRIGATORIAMENTE devemos checar problemas técnicos.

CA	GA	DA
Cabos	Ganho – FV/TV	Derivação



ABORDAGEM SBV

ALGORITMO AESP OU ASSISTOLIA

(Não retardar a administração de adrenalina e o início das compressões)

1º DIAGNÓSTICO DE RITMO NÃO CHOCÁVEL – O QUE FAZER?

1ª ATIVIDADE: Compressões torácicas

2ª ATIVIDADE: Acesso venoso / adrenalina

3ª ATIVIDADE: Considerar via aérea avançada **CHECAR TUBO CAPNOGRAFIA FIXAR TUBO**

2 MIN DEPOIS: **CHECAR RITMO**

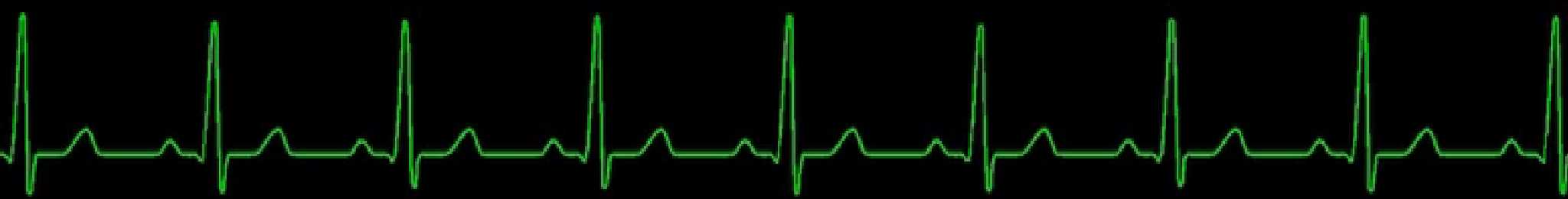
2º DIAGNÓSTICO DE RITMO NÃO CHOCÁVEL – O QUE FAZER?

1ª ATIVIDADE: Compressões torácicas

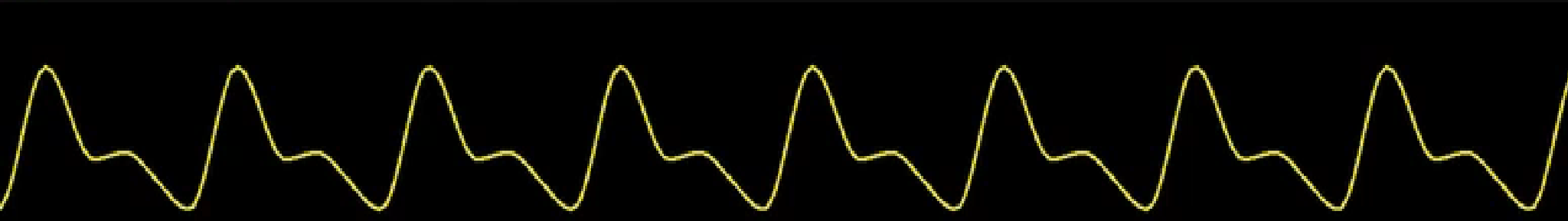
2ª ATIVIDADE: Preparar adrenalina-não administrar

3ª ATIVIDADE: Causas reversíveis (5h/5t)

2 MIN DEPOIS: **CHECAR RITMO**



60



SpO2

99



ABP

118/82

MAP

92

etCO2

kPa

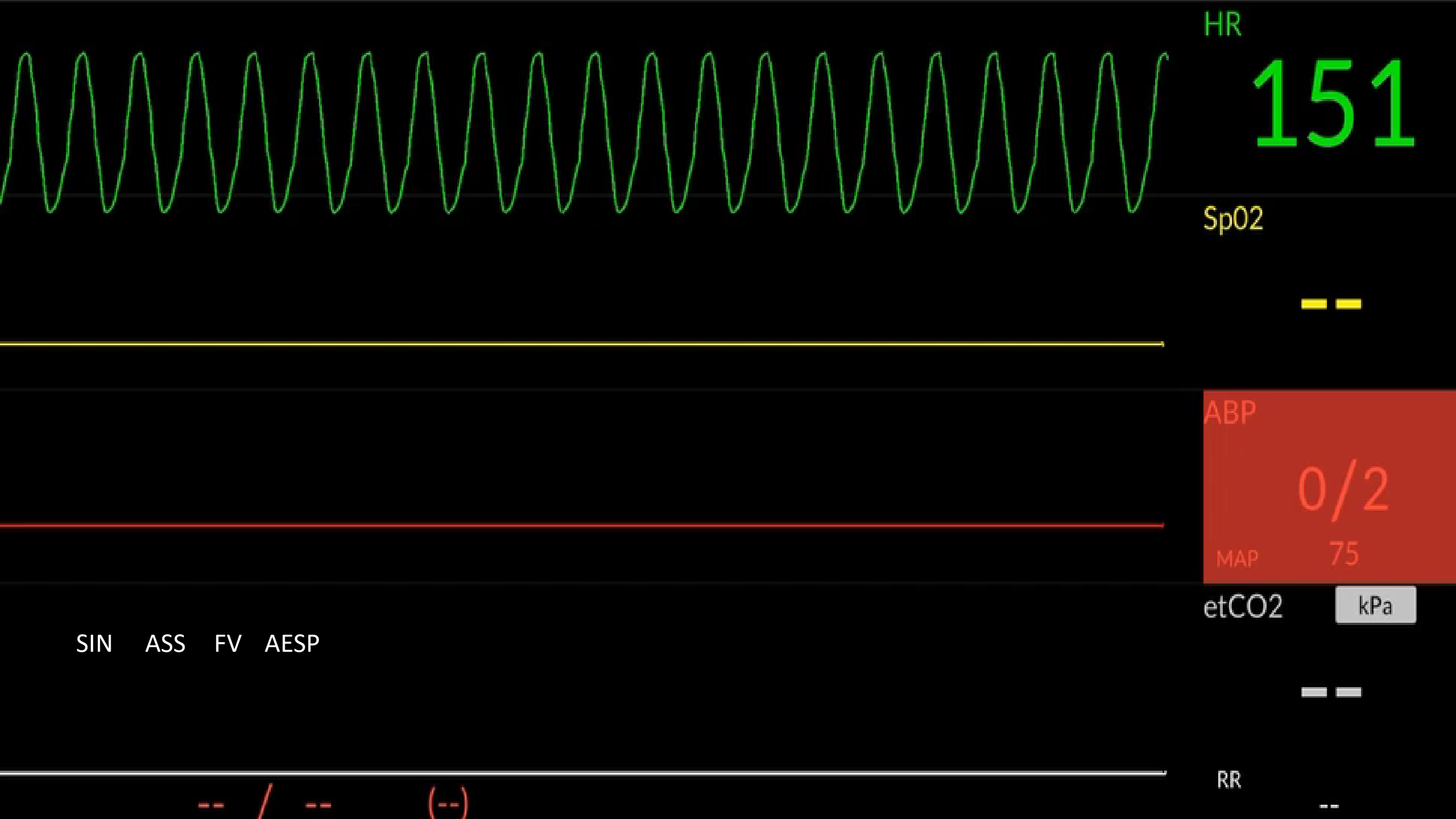
ASS FV AESP TVSP

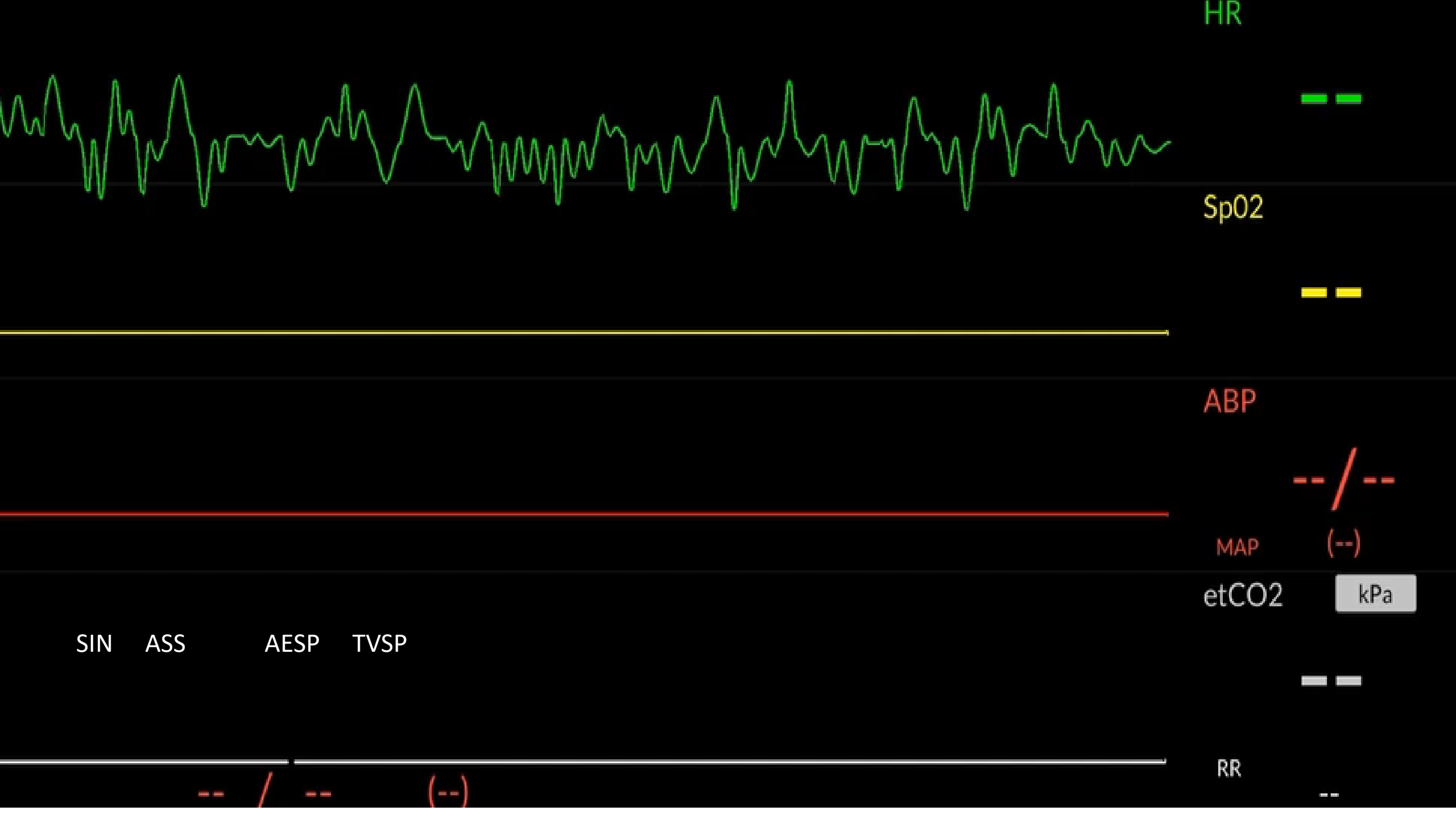
--

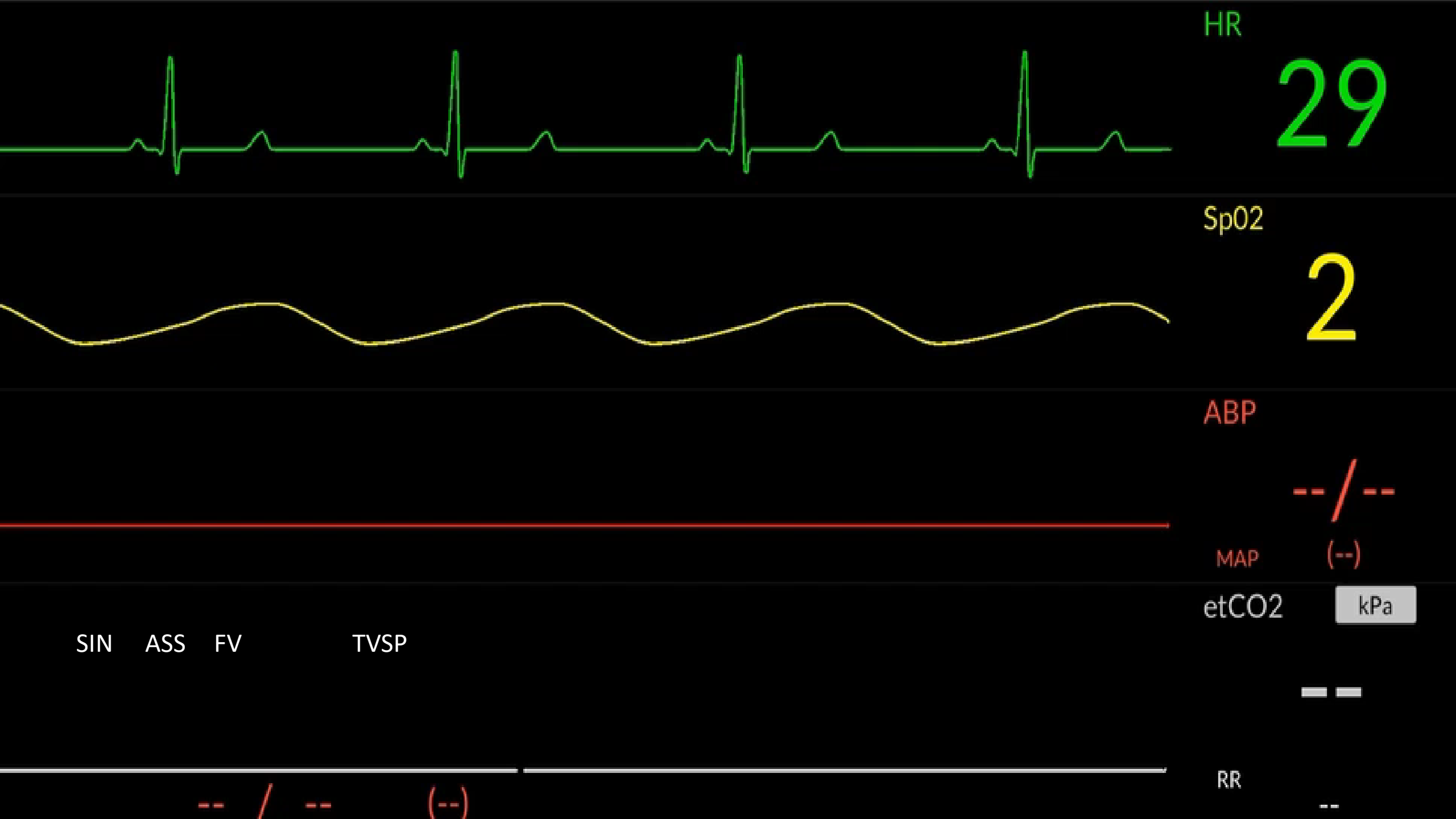
RR

--

-- / -- (--)







HR



--

SpO2



--

ABP



-- / --

MAP

(--)

etCO2

kPa

SIN

FV

AESP

TVSP

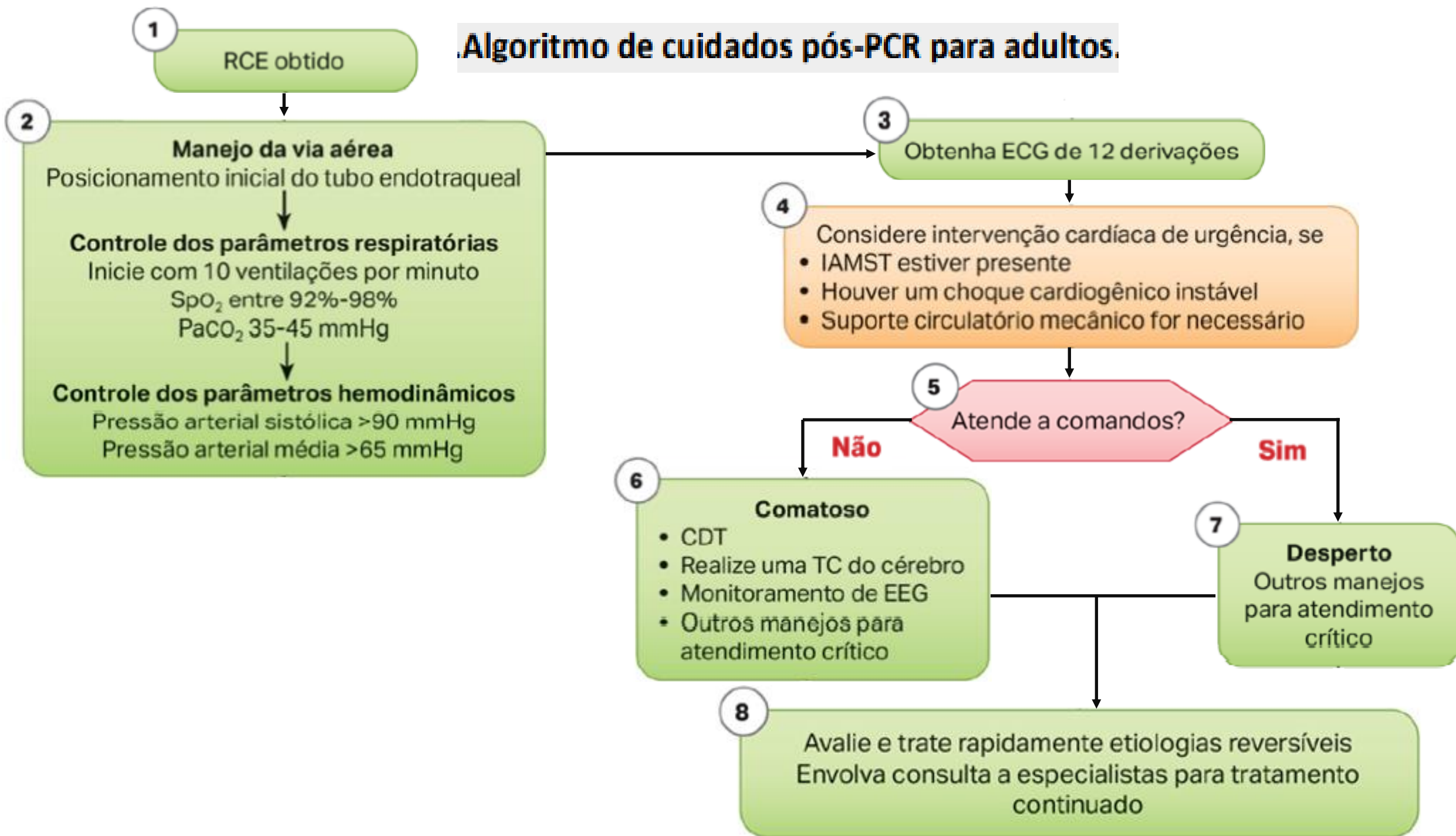
--

RR

-- / -- (--)

--

Algoritmo de cuidados pós-PCR para adultos.



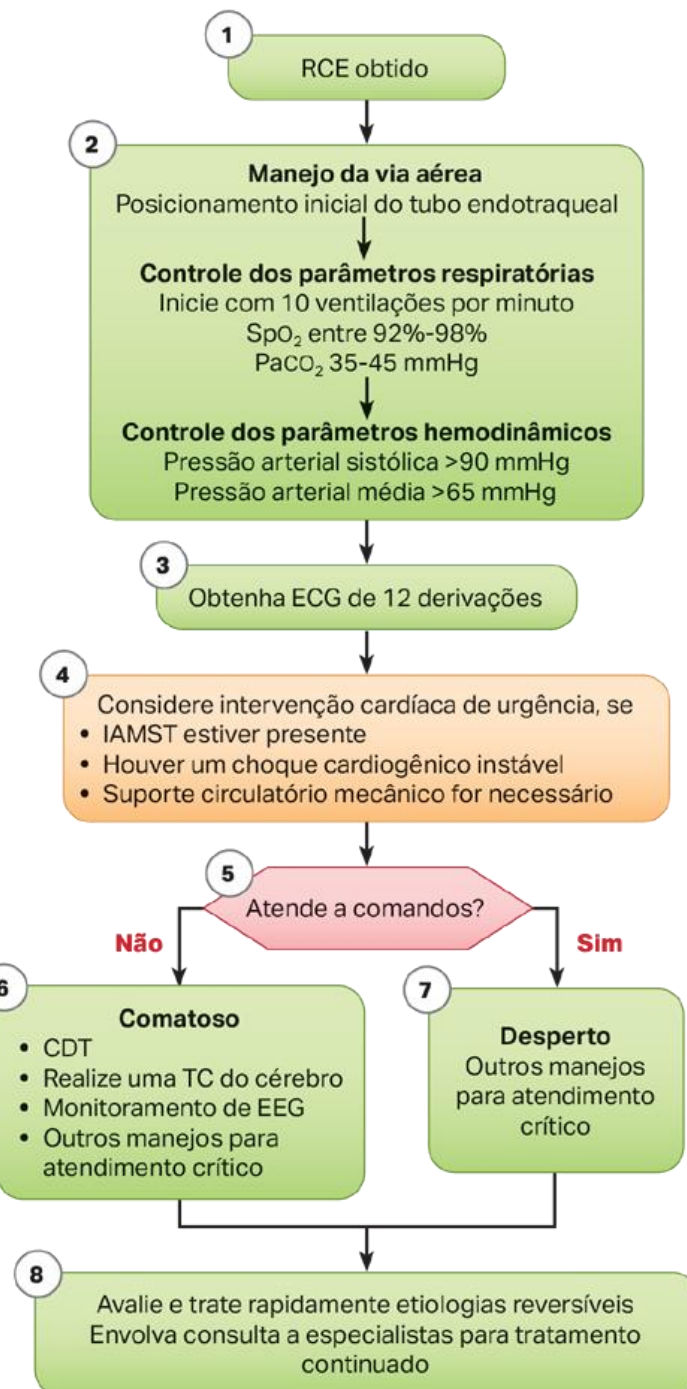
Fase de estabilização inicial

A ressuscitação é contínua durante a fase pós-RCE e muitas dessas atividades podem ocorrer ao mesmo tempo. No entanto, se a priorização for necessária, siga estas etapas:

- Manejo da via aérea: Capnografia com forma de onda ou capnometria para confirmar e monitorar o posicionamento do tubo endotraqueal
- Controle dos parâmetros respiratórios: Titule FiO_2 para SpO_2 de 92%-98%; inicie em 10 ventilações/min; titule para PaCO_2 de 35-45 mmHg
- Controle dos parâmetros hemodinâmicos: Administre cristaloides e/ou vasopressores ou inotrópicos visando uma pressão arterial sistólica >90 mmHg ou pressão arterial média >65 mmHg

Fase de estabilização inicial

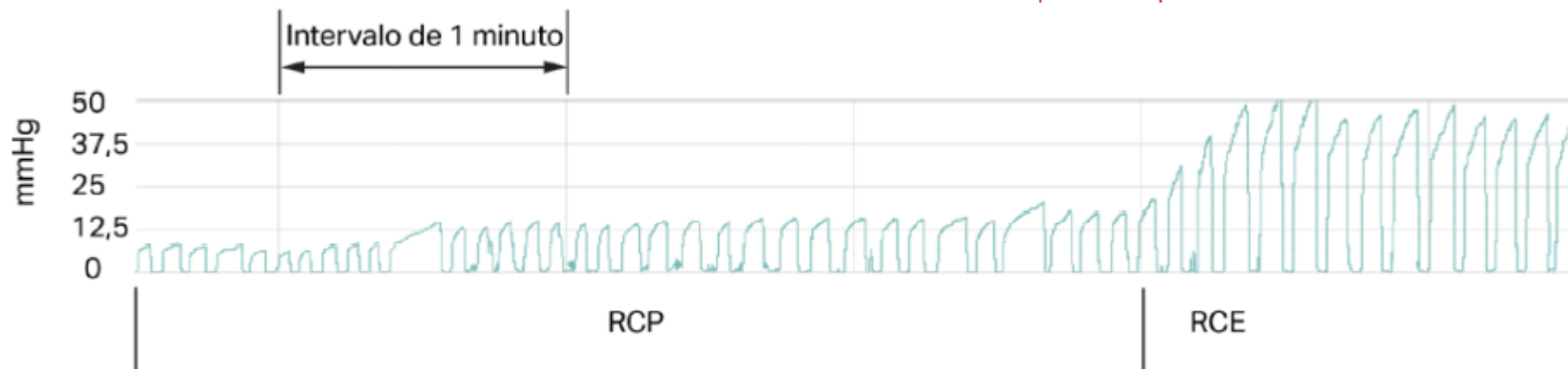
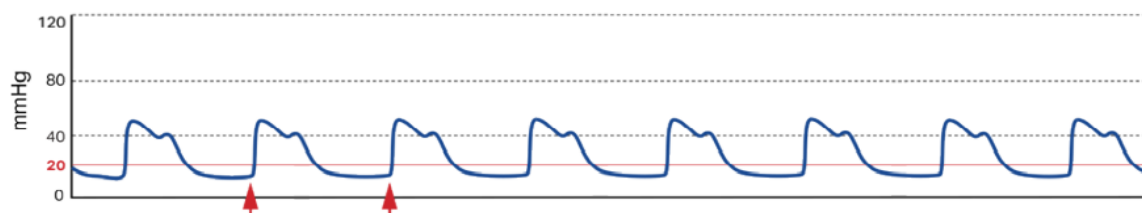
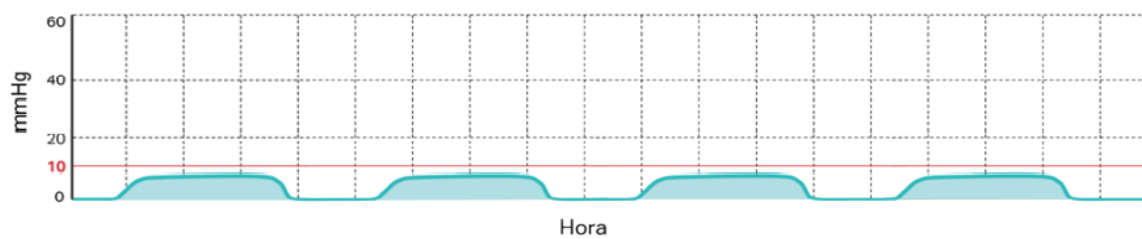
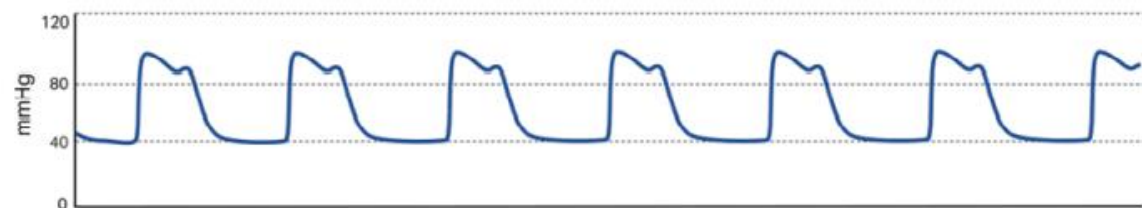
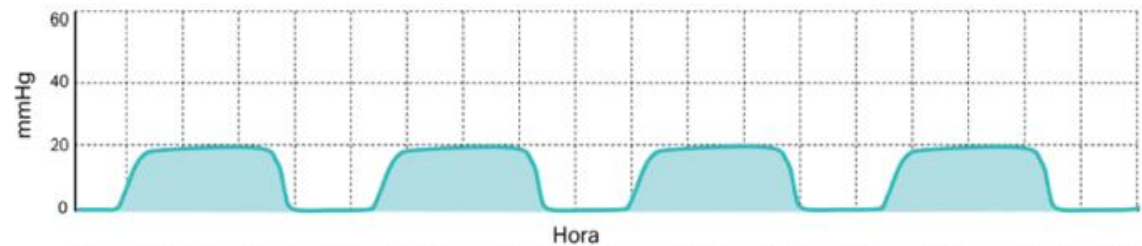
Manejo contínuo e atividades de urgência adicionais



Manejo contínuo e atividades de urgência adicionais

Essas avaliações devem ser realizadas ao mesmo tempo, para que as decisões sobre o controle direcionado da temperatura (CDT) recebam alta prioridade como intervenções cardíacas.

- Intervenção cardíaca de urgência: avaliação inicial de eletrocardiograma (ECG) de 12 derivações; considere a hemodinâmica para tomar decisões em intervenções cardíacas
- CDT: se o paciente não estiver atendendo comandos, inicie o CDT assim que possível; comece entre 32 °C e 36 °C durante 24 horas usando um dispositivo de resfriamento com ciclo de feedback
- Outros manejos para atendimento crítico
 - Monitoramento contínuo da temperatura central (esofágica, retal, bexiga)
 - Manutenção de normoxia, normocapnia e euglicemia
 - Monitoramento contínuo ou intermitente por eletroencefalograma (EEG)
 - Ventilação de proteção dos pulmões



ALGORITMOS ACLS – RETORNO À CIRCULAÇÃO ESPONTÂNEA (RCE)

O PACIENTE APRESENTOU PULSO!!

A: MANEJO DA VIA AÉREA

VIA AÉREA AVANÇADA: Estabelecer via aérea avançada ou checar
Capnografia **PETCO₂: 35 A 45 mmHg**
Fixar o tubo

B: RESPIRAÇÃO

AUSCULTA PULMONAR:

OXIMETRIA **SATO₂: 92 A 98%**

C: CIRCULAÇÃO (HEMODINÂMICA)

PA SISTÓLICA: ≥ 90 mmHg

PAM: ≥ 65 mmHg

HIPOTENSO? Solução salina 1 a 2 l
DVA – Noradrenalina

D: AVALIAÇÃO NEUROLÓGICA

Considerar o controle direcionado de temperatura = 32 a 36°C

E: EXAMES

Exames laboratoriais / ECG

INSTITUIR O CDT